PROCESO ASISTENCIAL A LA PERSONA CON RIESGO DE CONDUCTA SUICIDA EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

Elaborado por el Grupo Asistencial Salud Mental CES 061

Marzo 2023

Centro de Emergencias Sanitarias
061 Andalucía

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

Proceso asistencial a la persona con riesgo de conducta suicida en emergencias prehospitalarias © 2023 by Grupo de trabajo asistencial del grupo de Salud Mental (CES061-Andalucía) is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

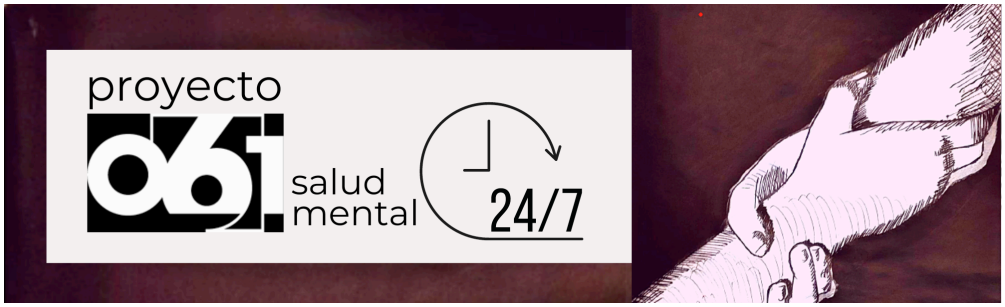
ISBN 978-84-09-68359-8

Repositorio Institucional de Salud de Andalucía. Centros de Emergencias.

Editado por Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y CES 061Andalucía

ÍNDICE

ÍNDICE 3
AUTORÍA 5
INTRODUCCIÓN 7
JUSTIFICACIÓN 8
OBJETIVOS 10
Objetivo principal 10
Objetivos secundarios 10
ALCANCE 12
DEFINICIONES 13
PROCESO ASISTENCIAL 15
7.1 Asistencia a paciente con intento suicida o crisis suicida 15
7.2 Atención a la familia/allegados. 29
7.3 Atención a personas por otros motivos (No intentos de suicidio) con Comunicación suicida o deseos de muerte 31
RECOMENDACIONES SOBRE EL IMPACTO EN PROFESIONALES SANITARIOS 35
ANEXOS 37
ANEXO 1. FACTORES DE RIESGO 38
ANEXO 2. FACTORES PROTECTORES 40
ANEXO 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 41
METODOLOGÍA 43
ACRÓNIMOS 46
BIBLIOGRAFÍA 47


proyecto
061
salud
mental
24/7

AUTORÍA

SUSANA DE CASTRO GARCÍA. Enfermera del CES 061 de Jaén

CARIDAD PETRI DE LUNA. Médica del CES 061 de Málaga

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ IZQUIERDO. Médico del CES 061 de Huelva

Revisión de expertos

- MIGUEL GUERRERO DÍAZ. Psicólogo clínico. Coordinador Unidad de Salud Mental Comunitaria Marbella. UGC Salud Mental Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga
- MIGUEL RUÍZ VEGUILLA. FEA de Psiquiatría. UGC Salud Mental Hospital Virgen del Rocío.

Apoyo metodológico:

- ÁNGEL LUIS MENA JIMÉNEZ. Licenciado en Humanidades. Técnico Escuela Andaluza de Salud Pública.
- MARIOLA BERNAL SOLANO. Doctora en Antropología de la Medicina. Profesora colaboradora Escuela Andaluza de Salud Pública.

> La prevención del suicidio es una prioridad mundial y se debe hacer todo lo posible por mejorar el reconocimiento precoz del suicidio inminente, por atender a las personas con conducta suicida y por fortalecer las estrategias de prevención del suicidio. Y el primer paso para conseguirlo, es adquirir conocimiento en este campo. (1)

Esperamos que este proceso asistencial contribuya a este objetivo tan importante.

INTRODUCCIÓN

Un manejo adecuado de los pacientes con conducta suicida puede contribuir a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad de la conducta suicida, y uno de los elementos esenciales para conseguir este manejo adecuado es la formación. La creación de protocolos para guiar y establecer consenso entre los distintos profesionales con capacidad de tomar decisiones en estas situaciones, dentro y fuera de los hospitales, mejoraría la implicación y la inclusión de estas personas en redes de salud, permitiendo su monitorización por profesionales de atención comunitaria con un punto de vista de la prevención del suicidio(2).

JUSTIFICACIÓN

El suicidio es un problema social y de salud pública de primer nivel, y una de las principales causas de muerte en el mundo. Por cada suicidio, hay veinte personas que lo intentan y otras 25 que lo piensan(3). El suicidio se mantiene como primera causa de muerte no natural o externa en nuestro país(4). Es una de las principales causas de años perdidos y un indicador de salud de la población(5).

El **Suicidio** nos afecta a todos, con independencia de la edad, país, sexo, profesión o condición social, entre otros factores.

En 2.021 se han suicidado en España 4.003 **personas**, de las que 849 lo hicieron en Andalucía.

Fueron 2.982 Hombres y 1.021 Mujeres. De entre las personas que se quitaron la vida, 14 chicos y 8 chicas tenían menos de 15 años.

El **13%** de las personas que se suicidaron tenía más de 79 años.

PERO HAY ESPERANZA. CUANDO LAS PERSONAS, ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y PROFESIONALES NOS UNAMOS PARA TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

Elaboración propia con datos publicados por el INE y Observatorio del Suicidio en España.

Detrás de cada suicidio y de cada intento de suicidio hay una larga lucha individual. Un sufrimiento que se extiende a familiares, amistades y allegados de estas personas(6). El suicidio puede ser visto como un comportamiento motivado por el deseo de escapar de un dolor psicológico o emocional insoportable. Este dolor es mucho más que la suma de sentimientos y emociones negativas, convirtiéndolo en una experiencia personal, única e intolerable, especialmente cuando no hay cambios previsibles en el futuro. El *mental pain*, *psychological pain* o *psychage* son términos que encontramos en la literatura científica referidos al mismo constructo(7).

Con frecuencia, el ámbito de las urgencias es el primer lugar de contacto para personas con conducta suicida, estando los/as profesionales de estos servicios en una posición estratégica

para hacer la valoración del paciente y derivar al recurso más apropiados(5).

Uno de los fines de caracterizar este problema de salud pública y social, es conocer los factores de riesgo y posibilitar acciones preventivas(8). Por este motivo, es esencial que conozcamos el impacto de este problema en nuestro contexto de atención.

Desde el año 2015 al 2022, en nuestros Centros de Coordinación de 061 hemos recibido 57.104 demandas relacionadas con el Tipo de Demanda (TD) de Suicidio. A falta de mayor depuración de los datos, se objetiva desde 2018 un aumento progresivo en este tipo de demandas asistenciales. Tal es así que en 2022 la tasa de crecimiento interanual de llamadas recibidas por este motivo en relación a 2021 ha sido del 31,2%. Podemos afirmar también que la provincia de Málaga se mantiene de forma continua por encima del resto, y que, junto a Sevilla, en todo el periodo analizado suman el 47,3% de los casos. El 52% de las demandas gestionadas son de mujeres y el 48%, de hombres. Siendo la franja de edad mayoritaria la de los 40-45 años, sin perder de vista el casi 9% de personas en la década de los 10 a los 20 años y el 6,3% de personas > 70 años. Con un 2,6% de personas fallecidas en este periodo de casi 8 años.

No hemos analizado aún los datos de las asistencias que hemos llevado a cabo con recursos 061, pero en el año 2021 según datos preliminares, realizamos alrededor de 400 asistencias relacionadas con intentos de suicidio en toda Andalucía.

Los trastornos afectivos y psicóticos, así como los trastornos de personalidad están considerados factores de riesgo de suicidio, destacando, con una asociación más fuerte que el resto, la depresión. En el Anexo 1 se muestran los factores de riesgo detallados en una revisión sistemática con meta-análisis publicada en 2022(9).

La OMS, en su informe sobre el suicidio de 17 de junio de 2021(10) advierte que, aunque la relación entre depresión y suicidio o ingesta de alcohol y suicidio están bien documentadas, existen otras circunstancias en las que las personas expuestas a crisis de diversa índole (dolor, problemas de relación, crisis económica, etc.) ven sobrepasada su capacidad de afrontar la vida y pueden tener una conducta suicida. Asimismo, son muchos autores los que coinciden en destacar que haber tenido intentos previos de suicidio aumenta el riesgo del mismo.

El estudio de Teresa Pacheco Tabuenca et al., mencionado previamente, resalta que el periodo inmediatamente posterior a la atención en urgencias es de alto riesgo, y el seguimiento y la adherencia al sistema sanitario de quienes han sido atendidos por un intento de suicidio se asocia con disminución del riesgo de repetición de la conducta suicida (5).

Con estas premisas constatamos la necesidad de elaborar un protocolo de atención sanitaria para abordar de forma adecuada a las personas con conducta suicida en el contexto de la atención urgente y emergente.

OBJETIVOS

Objetivo principal

- Atender de manera integral a la persona con riesgo de conducta suicida y a su familia y/o allegados, desde la asistencia sanitaria prehospitalaria.

Objetivos secundarios

- Asistir a la persona con crisis suicida de manera integral.
- Identificar y activar el Código Suicidio[1].
- Valorar y establecer las derivaciones que procedan en cada caso.
- Proporcionar información y soporte adecuados a la familia/allegados, incluso en los casos de fallecimiento.
- Detectar de forma precoz a personas vulnerables en relación a la conducta suicida para mejorar su acceso a servicios sanitarios.
- Trabajar de forma coordinada con otros agentes clave en este problema de salud.

[1] El Código Suicidio se está trabajando a nivel regional desde el PISMA. Cuando estén definido y establecidos los pasos a seguir, se incorporará a este documento.

Los objetivos planteados nos permitirán, desde nuestro ámbito de atención, utilizar diferentes herramientas para erradicar los mitos que rodean al suicidio y poder abordarlo sin tabúes ni estigmas, favorecer una relación de confianza con la persona y su familia/allegados, y realizar una atención inicial adecuada.

Será imprescindible hacer una derivación del/de la paciente a los recursos sociosanitarios disponibles en distintos ámbitos asistenciales (Urgencias Hospitalarias, Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental (UGCSM), Salud mental comunitaria, Atención Primaria, Salud Responde), garantizando así un plan de actuación que posibilite la prevención del acto suicida(11).

Aun con la dificultad que esto conlleva, este protocolo, junto a la formación necesaria que debemos recibir, nos ayudará también a detectar a personas que puedan verbalizar ideación suicida o que expresen dolor emocional importante que pueda derivar en conducta suicida si no se atiende de forma precoz y adecuada. Encontrar a estas personas en el ámbito de la emergencia sanitaria prehospitalaria, independientemente de la patología que presenten y comenzar a prestar atención a su situación, podría contribuir a la prevención del suicidio y a evitar una conducta suicida en el futuro(12) (13).

Dentro del Modelo **USI** (**U**niversal-**S**elective-**I**ndicada) de las estrategias de prevención del suicidio, este protocolo se enmarca dentro de la prevención Selectiva e Indicada [2].

[2] Prevención Selectiva: Dirigida a grupos vulnerables de la población, con factores de riesgo para la conducta suicida que sean identificados de forma precoz. Prevención Indicada: Dirigida a personas que expresan conducta suicida (ideación y/o intentos de suicidio)

ALCANCE

Profesionales de emergencias sanitarias. Profesionales de Equipos de Emergencias o Equipo de Coordinación Avanzada de 061 Andalucía que intervienen de forma directa con el/la paciente y entran en contacto con sus familiares o allegados.

Profesionales de Urgencias Hospitalarias. Médicos/as y enfermeras/os de urgencias, FEA de Psiquiatría de guardia y otros profesionales de Urgencias hospitalarias que intervienen tras la derivación por parte de los profesionales de atención prehospitalaria, a pacientes con conducta suicida que requieren procedimiento de urgencia.

Profesionales de Atención Primaria y de las Unidades de Salud Mental Comunitaria, que intervienen para la valoración del/la paciente atendido previamente y derivado por los profesionales de atención prehospitalaria, en los casos en que no se requiere procedimiento de urgencia.

Profesionales de Salud Responde. Enfermeras/os y Gestores/as telefónicos/as de Salud Responde que intervienen para dar seguimiento y monitorización al paciente con conducta suicida derivado por los profesionales de atención prehospitalaria.

DEFINICIONES (14),(15)

CONDUCTA SUICIDA: Es toda conducta autodestructiva independientemente de su heterogeneidad en la forma o expresión. Se utilizará este término como concepto genérico que incluye ideación, comunicación y actos suicidas (intentos y suicidios consumados).

IDEACIÓN SUICIDA: Hace referencia a pensamientos de querer quitarse la vida, sin implicar ningún comportamiento. Hablamos de cogniciones, ideas, imágenes, deseos, dirigidos a querer acabar con la propia vida. La ideación suicida varía en función de parámetros como su frecuencia, intensidad, duración o capacidad para inhibirlos. Cuando existe determinación de llevar a cabo el suicidio hablamos de intencionalidad suicida. La presencia de ideas suicidas motiva a la persona a realizar un intento por lo que es considerado un factor de riesgo y un antecedente de actos suicidas. Sin embargo, no todas las personas que manifiestan ideas pasan al acto.

PLAN SUICIDA: Cuando la ideación suicida se elabora y estructura en torno a un plan de querer acabar con la propia vida. Implica determinar un método suicida, un lugar, fecha o situación concreta para llevar a cabo el suicidio. La planificación suicida varía en función de la concreción o premeditación detallada del intento. A mayor planificación, mayor riesgo de suicidio.

INTENTO DE SUICIDIO: Conducta autoinfligida de forma voluntaria, consciente e intencional, con expectativas de muerte que no resulta fatal, bien por la interrupción propia o de terceros, por el fallo del método suicida utilizado o por la intervención de los servicios médicos (rescate). Se utilizará esta etiqueta independientemente de la intencionalidad, motivación o letalidad del método suicida.

SUICIDIO CONSUMADO: Acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende conseguir los cambios deseados. Debe existir intención expresa de querer morir en el acto.

COMUNICACIÓN SUICIDA: Cualquier acto interpersonal a través del cual se transmite, de forma verbal o no verbal, los deseos, las ideas o la intención de querer quitarse la vida. La comunicación puede ser directa o indirecta (a través de señales de alarma). Incluye en este concepto expresar a un tercero la intención o el deseo de querer matarse, y las expresiones verbales y no verbales de suicidio.

Otros conceptos no incluidos en este proceso, pero que interesa conocer para facilitar la discriminación e identificación de los términos son:

AUTOLESIÓN SIN FINALIDAD SUICIDA: Conductas autolesivas que causan un daño directo y deliberado a uno mismo, pero sin intención de querer acabar con la propia vida y sí buscando otras motivaciones diferentes. Puede ser una conducta lesiva directa (quemaduras, cortes, golpearse a sí mismo, etc.) o indirecta (conductas destructivas como consumo de drogas, promiscuidad, etc.). NOTA: si hay una autolesión con intención suicida mejor categorizar como intento de suicidio a través de método autolesivo (ver en apartado de codificación diagnóstica).

DESEOS DE MUERTE: Ideas de querer morir o no querer vivir, que no implican intención o determinación a querer matarse. También se utiliza el término “idea pasiva de muerte” siempre que no hay intención de iniciar un acto suicida. Son muy habituales en la población general y suelen ser señal de sufrimiento o malestar emocional intenso.

RIESGO SUICIDA: Grado variable en términos probabilísticos de llevar a cabo un acto suicida.

PROCESO ASISTENCIAL

7.1 Asistencia a paciente con intento suicida o crisis suicida

Las personas que sufren crisis de salud mental reciben una asistencia más variable y de peor calidad que las que sufren crisis de enfermedad física(16).

Los dos mayores obstáculos que impiden que los pacientes con enfermedades mentales reciban el cuidado y atención adecuados son: **las actitudes negativas y el estigma que rodea a la enfermedad mental**(17). En relación al suicidio, estudios en nuestro entorno sanitario concluyen que los profesionales sanitarios estudiados muestran creencias actitudinales desfavorables y estigmatizantes ante personas con conducta suicida con independencia del tiempo trabajado(2) o el ámbito de atención (Urgencias hospitalarias, Atención Primaria), siendo en algunos casos la experiencia personal con el suicidio la que se correlaciona con una mayor aceptación al comportamiento suicida(18).

En este proceso asistencial se establecen aspectos esenciales para llevar a cabo la atención de mayor calidad posible a estas personas y sus familias/allegados.

El Equipo 061 activado (Equipo de Emergencias o Equipo de Coordinación Avanzada (ECA)) debe recibir por parte del Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias (CCUE) la información más completa posible sobre la situación del/de la paciente durante la aproximación al lugar. Esto incluiría:

- Información facilitada por el/la paciente o alertantes
- Lugar donde se encuentra esta persona (domicilio/espacio público) y circunstancias que rodean al hecho.
- Datos básicos de la situación clínica
- Si hay en el lugar o se han activado Fuerzas de Seguridad y de Rescate
- Si se han identificado riesgos, de qué tipo y alcance
- Si está solo/a o hay familia/allegados

- Presencia de niños/as (sobre todo si el paciente sólo está acompañado/a de niños/as o adolescentes)

En la aproximación, es importante apagar las sirenas de la ambulancia al acercarnos al lugar de la asistencia, para evitar estímulos estresantes que puedan afectar a la persona con conducta suicida.

Si el/la paciente está identificado de forma inequívoca y procede hacerlo, podemos consultar información de su Historia de Salud desde la Historia Clínica Digital en Movilidad (HCD_M).
Si se han activado otros primeros intervinientes (Policía, Bomberos…), hay que contactar con los responsables operativos para la actuación conjunta si fuera preciso (se trabajará un protocolo coordinado con Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Bomberos).
Si no fuera precisa la intervención de estos operativos (ej: dentro de un domicilio, sin riesgo para paciente, familiares ni profesionales), les pediremos que se mantengan al margen de la atención para conseguir un espacio de mayor intimidad con la persona(19).
A la llegada, tener siempre presente la Seguridad del paciente y del Equipo Sanitario(17),(19),(20).

En relación al Equipo Sanitario:

- Equiparnos con los EPI que procedan en base al tipo de asistencia
- Ubicar la Unidad Móvil en lugar adecuado y coordinado, si fuera el caso, con otros operativos
- No se accederá a ningún lugar de riesgo hasta que no esté controlado por los operativos de Rescate o Seguridad. Si no fuera posible el acceso, esperaremos a que traigan al paciente al lugar de espera
- Tener siempre controlado el equipamiento que utilizamos en las asistencias (mochilas, monitor-desfibrilador, botella de oxígeno…)
- Elegir, en la medida de lo posible, el lugar de atención que tenga vía adecuada (entrada, salida) y espacio suficiente de atención.

En relación al paciente:

- Asegurar que no hay armas o materiales peligrosos que pueda utilizar la persona
- Agrupar y controlar medicación y otras sustancias que el paciente haya podido ingerir
- Asegurar que no esté cerca de ventanas o accesos de riesgo
- No dejar al paciente solo/a en ningún momento

- Retirar a otra estancia a personas que puedan alterar al paciente y obtener información sobre lo ocurrido de estas personas
- Proteger a los niños/as si los hubiera
- Valorar si existe agitación o riesgo de violencia que deba ser controlado

Si la situación del paciente es crítica, se actuará en base al proceso asistencial correspondiente, con el tratamiento y cuidados que el/la paciente necesite.

Una vez estabilizada la persona, atender la situación emocional y lo relativo a la conducta suicida.

Si la situación del paciente está controlada y no reviste gravedad, comenzar a abordar a la persona desde el hecho ocurrido.

Consideraciones que facilitan un **acercamiento humanizado a la persona** (19, 20).

- Acercarse con calma haciendo contacto visual
- Presentarse y decir que estamos ahí para ayudarlo/a y preguntar su nombre
- Mantener tono de voz firme y empático
- Observar su comunicación no verbal (distante, atento, calmado, agresivo, temeroso, asustado, avergonzado, triste...)
- Dar espacio para que procese y responda (respetar los tiempos[3])
- Informar de lo que se va haciendo (toma de constantes, monitorización, vendaje de heridas...)
- Supervisar al paciente en todo momento, sin dejarlo solo/a
- Si hay familia[4]/allegados en la escena, preguntar a esta persona si quiere que estén o no presentes durante la asistencia
- Tener en cuenta aspectos culturales para dar un soporte adecuado
- No hacer falsas promesas al paciente

[3] Los tiempos son los del paciente. No atosigar a preguntas. La asistencia en estas circunstancias debe "ralentizarse" para poder establecer una relación de confianza.

[4] Es importante recoger información de la familia/allegados en otro espacio distinto de donde se encuentra el paciente. Si la situación clínica lo permite, los profesionales del Equipo pueden dividirse para hacerlo

En el momento que sea posible, se deberá **realizar una entrevista clínica** con la persona para facilitar que hable sobre lo ocurrido. La entrevista la iniciará un solo interlocutor (el/la profesional que esté mejor preparado/a para hacerla). La entrevista será dinámica durante la atención y traslado del paciente. Es importante utilizar un lenguaje cognitivo: "¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuándo te has decidido a hacerlo? ¿Cuál era tu plan? ¿Qué ha provocado que lo hicieras ahora?"

Una de las premisas clave es: Animar al paciente a expresar lo que siente.

Sin culpar, sin represaliar o manipular y sin emitir comentarios educativos, moralizantes o "tópicos", intervendremos con empatía y respeto, escuchando, validando el dolor emocional[5] o psicológico, y facilitando la ventilación emocional (ej: Entiendo que estés sufriendo por esto; Es normal que te hayas sentido así después de lo que te ha ocurrido; Ha debido ser muy difícil pasar por esto que nos cuentas…). No es el objetivo quitarle las ideas suicidas, sino aplazar la decisión y que pueda ver que el suicidio es un acto irreversible para una situación que puede ser temporal y que puede cambiar. Si ha sido esa persona la que ha pedido ayuda, reconoceremos la importancia de lo que ha hecho.

Queremos sembrar o fomentar la ambivalencia que sienten muchas personas en este momento.

Hacer una escucha activa es vital para encontrar los puntos de anclaje a la vida para esa persona. Solo si dejamos que haga un relato de lo que siente, podremos identificar aquello por lo que le costaría seguir adelante en ese intento de suicidio. Precipitarnos pensando que los hijos/as, padres, parejas o cualquier otro aspecto que le de sentido a nuestra vida, hará el mismo efecto en esa persona, es un error que debemos evitar(21). El proyecto vital de cada persona es exactamente eso, absolutamente personal. No se trata de comparar nada sino de conseguir establecer una relación de confianza que facilite que esa persona exprese, si así lo siente, por lo que valdría la pena seguir viviendo.

[5] Validar el dolor emocional es tan importante como validar el dolor físico que sienten las personas que atendemos. Validar significa aceptar, entender y atender ese dolor que expresa la persona, sin minimizarlo ni relativizarlo, porque es absolutamente personal y forma parte del sufrimiento que está sintiendo esa persona.

Fundamental indagar y comprobar las dimensiones contenidas en el siguiente cuadro:

ANTECEDENTES/ TRATAMIENTO	Enfermedad física, enfermedad mental, otro tipo de trastornos. Tratamientos activos(22) (psicofármacos: antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizantes del estado de ánimo) y tiempo de tratamiento (Historia de salud mental previa o actual, si está activo el tratamiento o lo abandonó, qué terapia/tratamiento tenía…). Otros: ACO-ADNI-Insulina-AINES-Paracetamol-Opiáceos.
CONDUCTAS DE RIESGO/FACTORES DE RIESGO (Anexo 1)	El intento de suicidio se considera una conducta de riesgo y un factor de riesgo al mismo tiempo. Incluir cualquier otra que pueda presentar la persona (consumo de alcohol u otras sustancias, pérdida de algún factor de protección, Violencia de Género, etc.).[6]
INTENTOS PREVIOS DE SUICIDIO	¿Cuándo ocurrió? ¿Qué método utilizó? Letalidad del mismo. ¿Necesitó rescate?
SITUACIÓN FAMILIAR/RELACIONAL	Si está solo/a o acompañado/a, si podemos identificar red de apoyo social y/o familiar. Identificar a la persona de referencia con nombre, parentesco y teléfono.
FACTORES PRECIPITANTES	Debut enfermedad mental, ruptura sentimental, despido, pérdida de ser querido, malos tratos, Violencia de Género, pérdida de trabajo, pérdida de estatus económico, minorías que se enfrentan a discriminación, rechazo, ciberbullying (personas LGTBQ, otras etnias(23), etc), alta de Unidad de hospitalización de Agudos en los últimos 10-15 días.
FACTORES PROTECTORES (Anexo 2)	Si se identifican (personales, familiares, sociales). Se trata de ver si la persona expresa "razones para vivir"(24) ¿Qué puede mantener a la persona unida a la vida?

[6] Algunos expertos hablan de la "**Capacidad de Suicidio**" que incluye aquellos factores que median entre la Ideación Suicida y el Acto Suicida. Así, hablan de factores interpersonales o adquiridos, como condiciones que, mantenidas en el tiempo, pueden moldear un comportamiento más proclive al suicidio. Algunas de ellas son exposición al sufrimiento de manera mantenida, elevada tolerancia al dolor, vulnerabilidad sostenida en la biografía de la persona, adquisición de conocimiento sobre suicidio, facilidad de acceso a medios letales, carga percibida o sentimientos de baja pertenencia. Algunos de estos aspectos los hemos recogido en diferentes apartados de la tabla anterior.

Cuando atendamos a una mujer con conducta suicida, se indagará de forma proactiva sobre **Violencia de Género**, ya que como vemos en la tabla anterior, ésta es una condición reconocida como Factor de Riesgo y como Factor precipitante para el Suicidio. Podemos utilizar algunas de las preguntas facilitadoras que se recogen en el "Manual de Cuidados de Enfermería a mujeres que sufren Violencia de Género y a sus hijas/os". Por ejemplo:

- ¿A qué cree que es debido su sufrimiento o dolor emocional?
- ¿Tiene usted algún conflicto con su pareja?. Si lo tiene, ¿cómo lo maneja?
- ¿Le gusta cómo la tratan en casa? ¿Cómo van las cosas en casa?

Si se detecta esta situación (Malos tratos confirmados (CMT) o Indicador de sospecha de malos tratos (ISMT)) se llevarán a cabo todas las acciones que procedan (asistenciales y legales) al respecto, sumadas a las que se describen en este proceso asistencial.

Se valorará el uso de **contención farmacológica** solo en casos de que fracase la contención verbal en:

Inquietud y agitación leve:

- Síntomas ansiosos no psicóticos: Benzodiacepinas (alprazolam, diazepam, clorazepato dipotásico, midazolam).
- Síntomas psicóticos: Neurolépticos tipo Haloperidol, con o sin Benzodiacepinas. La Ketamina(25) parece ser muy efectiva en casos de Depresión mayor.

Agitación por fármacos:

- Haloperidol (efecto más rápido).

Agitación grave:

- Neurolépticos tipo Clorpromacina (Largactil).

- En las situaciones de agitación, donde es necesario una disminución del riesgo de autolesiones o heteroagresividad[7], se recomendaría el uso de antipsicóticos intramusculares de nueva generación, con una rapidez de acción corta, y preferiblemente con bajo efecto de parkinsonismo como por ejemplo el Aripiprazol(26).

Ideas de Suicidio:

- Benzodiacepinas (tratamiento de la angustia vital).

Si presenta alucinaciones auditivas:

- Haloperidol o sedación (en función de la situación de esa persona).

[7] Valorar la necesidad de Fuerzas de seguridad de apoyo para la contención del paciente.

El uso de escalas específicas

Se muestran en el documento dos escalas utilizadas por otros servicios de emergencias prehospitalarias, así como en ámbitos de urgencias hospitalarias y Unidades de Gestión clínica de Salud Mental: La Escala de detección de Riesgo suicida MINI[8], con 6 preguntas sencillas y directas y la ESCALA SAD PERSONS, ésta con 10 ítems.

Ambas escalas tienen asociada una puntuación a cada uno de los ítems, que sumadas agrupan el riesgo de suicidio en leve o bajo, moderado o alto. Pero, "este número no es suficiente para discriminar entre quienes afirman que se van a suicidar y quienes realmente lo hacen"(24).

El uso de escalas nos permite objetivar información, para abordar a la persona en estas situaciones de forma directa y homogénea. Utilizar las preguntas de la escala MINI, nos ayudará a:

- No divagar en el momento de abordar el tema con la persona
- Emplear la terminología adecuada
- Enfocarnos para crear esa relación de confianza necesaria para que la persona se sienta con la libertad de hablar sobre sus sentimientos y emociones.

Hablar del suicidio con una persona en riesgo reduce el peligro de cometer el suicidio y puede ser la única posibilidad de esa persona de analizar su situación(19). Conectar con esa persona en el momento agudo del intento de suicidio puede iniciar el camino a la prevención en el que serán necesarios muchos profesionales de diferentes espacios de atención y periodos temporales.

La toma de decisiones se basará por tanto en la entrevista clínica que realicemos, en los datos que nos aportan las escalas y los apartados de la tabla anterior, la comunicación verbal y no verbal de la persona, así como toda la información que se desprende de la escena y el contexto de la asistencia.

[8] MINI: Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional.

Escala MINI

ESCALA MINI

Durante este último mes:			**Puntos**
¿Ha pensado que estaría mejor muerto, o ha deseado estar muerto?	NO	SI	1
¿Ha querido hacerse daño?	NO	SI	2
¿Ha pensado en el suicidio?	NO	SI	6
¿Ha planeado cómo suicidarse?	NO	SI	10
¿Ha intentado suicidarse?	NO	SI	10
A lo largo de su vida			
¿Alguna vez ha intentado suicidarse?	NO	SI	4

¿INDICÓ SI AL MENOS EN UNA RESPUESTA?

CADA RESPUESTA "SI" LLEVA ASOCIADA LA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA EN SU PREGUNTA CORRESPONDIENTE

RIESGO DE SUICIDIO	
1-5 puntos	LEVE
6-9 puntos	MODERADO
≥ 10 puntos	ALTO

Elaboración propia basada en las publicaciones y protocolos nacionales e internacionales que la incluyen.

Una o más respuestas afirmativas a las preguntas referidas de forma directa al suicidio, indican la necesidad de valoración urgente por FEA de Psiquiatría de guardia.

ESCALA SAD PERSONS	Puntos
Sexo Masculino	1
Edad <20 ó > 45 años	1
Presencia de Depresión	1
Intento previo de suicidio	1
Abuso de alcohol	1
Ausencia de pensamiento racional	1
Apoyo social inadecuado	1
Plan elaborado	1
Sin pareja	1
Problemas de Salud	1

0-2: Bajo riesgo
3-4 Riesgo moderado. Seguimiento ambulatorio o valorar ingreso
5-6: Riesgo alto. Se recomienda ingreso, especialmente si presenta ausencia de apoyo social
7-10: Ingreso hospitalario

Elaboración propia basada en la Fuente: Patterson et al.,1983 (87)

La presencia de depresión, intento previo de suicidio, abuso de alcohol, plan de suicidio y problemas de relaciones o apoyo social son factores de riesgo muy relevantes.
Cualquier intento de suicidio requiere derivación a hospital por parte del equipo 061 que está atendiendo al paciente.

En ambas escalas existe un ítem relacionado con la planificación del suicidio. Si la respuesta dada por el/la paciente es sí, preguntaremos por este plan para recoger, si es posible, información que pueda resultar relevante para el siguiente nivel asistencial.
Todo lo que nos aporte el/la paciente y su familia/allegados quedará reflejado en la HCD_M: antecedentes, ideación y planificación suicida, soporte familiar (con teléfono de contacto de la persona acordada con el/la paciente o la más cercana y conocedora de su situación en caso de no poder obtener esta información del propio paciente), reacción frente al intento suicida, gravedad del daño del intento, información de las escalas utilizadas. En resumen, todo lo expresado previamente.
Se precisa, además, cumplimentar de forma correcta el **Parte de lesiones al juzgado** describiendo el método utilizado, la situación clínica del paciente y las intervenciones y derivaciones llevadas a cabo.
Es esencial que utilicemos la **Codificación diagnóstica**[9] adecuada a esta situación. Esta codificación hará referencia tanto a la conducta suicida como al método utilizado causante de la afectación física.
Se utilizará el CIE-10. En el caso de Intento de suicidio se codificará con CIE-10: T14.91 Intento de suicidio, NEOM acompañado del CIE correspondiente al método: ej: Abuso de medicamentos, heridas de distinta índole, ahorcamiento, etc.
Importante: Las lesiones o manifestaciones de la tentativa suicida serán diagnóstico principal cuando sean la causa del ingreso hospitalario, seguidos de los descritos anteriormente. En caso de suicidio consumado se añadirá el CIE correspondiente a Óbito.
Si está asociada a un trastorno mental específico, codificar el trastorno a continuación.
En el caso de Ideación Suicida se codificará con su CIE-10: R45.851 Ideación Suicida.

[9] https://eciemaps.mscbs.gob.es/ecieMaps/browser/metabuscador.html

RESOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA

> "Los servicios de ambulancias de atención prehospitalaria tienen una oportunidad única de ofrecer una gama de posibles estrategias de prevención del suicidio mediante el desarrollo de vías de atención alternativas a los servicios especializados de salud mental, la prestación de intervenciones de prevención del suicidio y el registro del riesgo de suicidio al ingreso del paciente en las urgencias de Hospital" (11).

Toda persona que haya hecho un intento de suicidio debe ser derivada al hospital preferentemente por el Equipo sanitario que la está atendiendo (Esquema 1). En situaciones complejas, cuando existan dudas razonables o el paciente se niegue a ser atendido o trasladado al hospital, debemos pedir el apoyo de sus personas de referencia y si la situación lo requiere, consultar con un experto (ej: profesional especialista de la UGCSM) para que guíe nuestra actuación, en los casos en que así esté procedimentado con el hospital de referencia.
Durante el traslado, seguiremos obteniendo información de la situación de esta persona y ofreciéndole todo el apoyo y comprensión posibles.

Transferencia en Hospital:

Independientemente de la puesta en marcha del Código Suicidio, estos pacientes deben ser transferidos de profesional a profesional en la Urgencia hospitalaria. Aconsejamos llamar durante el traslado (a través del CCUE, pero con información directa de profesional a profesional) a médico/a de Urgencias de la llegada del paciente. En los casos en los que la persona no esté bajo los efectos tóxicos de medicación y otras sustancias, aconsejamos hacer esta llamada directamente al FEA de Psiquiatría de guardia. Informaremos de:

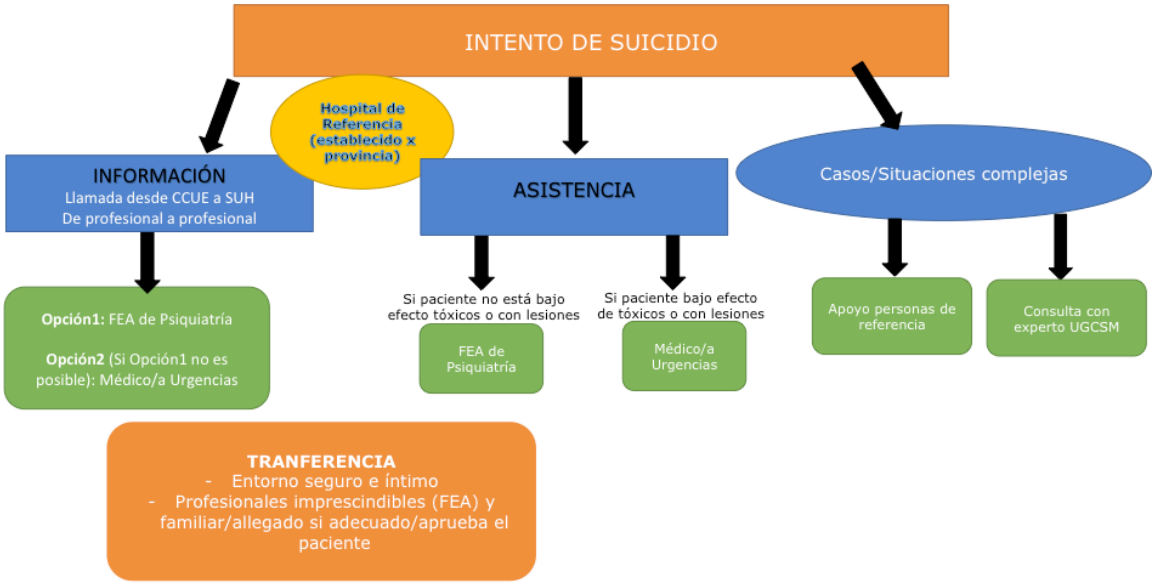
- Antecedentes de atención psiquiátrica y/o enfermedad física relevante y tratamiento
- Intentos de suicidio previos
- Soporte social o familiar (con teléfono, si es posible)
- Su reacción frente al intento
- Gravedad del daño del intento con valoración de la Escala de Glasgow con tres dígitos numéricos (OVM)

En cada provincia, deben estar establecidos los hospitales de referencia para la atención de estas personas, a través de un procedimiento específico consensuado en cada uno de ellos, según los recursos estructurales y profesionales de los que se disponga.

La transferencia se hará en el lugar adecuado acordado por ambas partes, garantizando un entorno seguro e íntimo. En la transferencia estarán presentes los/as profesionales del Equipo 061, los profesionales imprescindibles de Urgencias y algún familiar de referencia del paciente cuando sea adecuado y el/la paciente esté conforme. Cuando esté así procedimentado, también estará el FEA de Salud Mental referente para recibir información directa del equipo asistencial y establecer el momento de valoración idóneo del paciente[10].

Si se ha hecho contacto telefónico previo con este especialista, se informará al Médico/a de Urgencias.

El/la paciente debe quedar en un lugar seguro dentro del área de las Urgencias, facilitando el acompañamiento de familiar/allegados y en espacios con presencia de profesionales sanitarios. La persona debe ser valorada siempre por un FEA de Psiquiatría de guardia antes de proceder a su alta del hospital.



Esquema 1. Transferencia de paciente con intento de suicidio

[10] Actualmente los/as psiquiatras reciben la información por parte del médico/a de Urgencias. Es fundamental que Psiquiatras y/o Psicólogos referentes en cada UGCSM accedan, desde la HUSA del paciente, a la HCD_M que hemos realizado para ver lo ocurrido en la primera atención sanitaria de esa persona. Es una información muy relevante que deben conocer estos especialistas para poder proveer el tipo de tratamiento más adecuado.

Cuidados de Enfermería

Remitimos al/la profesional al documento de Cuidados en la atención urgente y emergente prehospitalaria(27), en el que se describe el enfoque de cuidados que llevamos a cabo en este entorno asistencial. Hay aspectos esenciales que debemos recoger en la situación basal del/de la paciente en relación a su independencia o no para las Actividades (básicas, instrumentales y avanzadas) de la Vida Diaria (AVDs), conductas/factores de riesgo, hábitos de vida y Régimen Terapéutico, en sentido amplio. Se recomienda cumplimentar las Necesidades Básicas (NB) que procedan en base a la situación del paciente. La valoración de las Necesidades Básicas de Comunicación, Seguridad, Valores (dejar por escrito aquellas expresiones que la persona verbalice en relación a sus valores y a la situación vivida) y Aprender son imprescindibles, y por supuesto todas aquellas que sean precisas según requiera el/la paciente. Es clave recoger cualquier aspecto relacionado con la familia o allegados que nos pueda proporcionar información sobre el soporte relacional de esa persona.

El Diagnóstico NANDA específico para estos casos es el **00289 Riesgo de conducta suicida**: Susceptible de actos autolesivos asociados a intención de morir. Se recogen en el Anexo 3, otros Diagnósticos de Cuidados (NANDA), Criterios de resultado (NOC) e Intervenciones (NIC) que podemos encontrar en estas situaciones y que se deben registrar en la HCD_M del/de la paciente.

Existe evidencia fuerte que muestra cómo algunos elementos del sistema sanitario reducen de forma fiable las tasas de suicidio. Estos incluyen nexos, conexiones y transferencias adecuadas entre distintos niveles de cuidados, acceso rápido a servicios como los de 24h (líneas de crisis), seguimiento asertivo de los pacientes con problemas de adherencia al tratamiento, entrenamiento continuo de los profesionales que atienden estas situaciones, y supervisión en la valoración y tratamiento del riesgo suicida. Estos y otros elementos han mostrado en Reino Unido una reducción de entre 22 y 29% en las tasas de suicidio(23).

Toda persona atendida con conducta suicida, desde la ideación a la crisis suicida, debe ser considerada persona vulnerable[11]. Los motivos deben quedar expuestos de forma clara en la HCD_M por parte de la Enfermera/o del Equipo 061/ECA. La detección de la vulnerabilidad conlleva la derivación a su EGC de referencia a través de la HCD_M, tal y como establece el documento específico sobre este tema(28).

---

[11] Pendiente incluir a la persona con conducta suicida como motivo de vulnerabilidad en la HCD_M.

La vulnerabilidad que como profesionales de la atención sanitaria prehospitalaria detectamos, no está sujeta exclusivamente a la situación de salud fisiológica de la persona, sino que contempla aspectos relacionados con lo familiar, lo social y las circunstancias ad hoc de las que somos testigos en la atención de esta persona en sus entornos más íntimos, así como su estado emocional para afrontar y manejar su contexto vital. Esto nos permite ver y ser conscientes de aspectos muy significativos que están afectando a estas personas y que no se pueden disociar de su momento vital. Todo debe quedar bien documentado en la historia clínica.

7.2 Atención a la familia/allegados.

"El peor día de mi vida comenzó como cualquier otro"

Así comienza Carmen el relato de la pérdida de su hermano Carlos por suicidio(29).
Un hecho que provoca un verdadero caos emocional. Un impacto brutal con miles de preguntas sin respuesta que inundan la mente de la familia/allegados, y una que llega incesante, en bucle: "¿Por qué?".
El momento de la noticia, de chocar con esa realidad cruda e insoportable puede ser recordado de forma muy variable por cada persona. Lo que describe Carmen en un pasaje de su libro, nos debe hacer tomar conciencia del enorme efecto que podemos tener en la vida de estas personas que acaban de sufrir una pérdida tan desgarradora como es la muerte por suicidio:

> "Enseguida la psicóloga del SAMUR se ocupó de mi madre, se sentó con ella y comenzó a hablarle, estuvo a su lado mucho tiempo diciéndole cosas, ayudándola a procesar todo lo que acababa de pasar. Me senté a su lado a escuchar, no recuerdo bien lo que nos dijo, solo sé que su presencia fue como una luz que nos hizo sentir tranquilidad en medio de ese inmenso y cruel caos que nos rodeaba, y nos ayudó a entender lo que estaba pasando desde una perspectiva realista, pero con serenidad. Su voz transmitía paz, algo casi impensable en ese momento de locura total."

Los supervivientes a una muerte por suicidio pueden manifestar sentimientos de enorme dolor, confusión, negación, remordimiento, culpa, rabia, vergüenza... Es esencial estar ahí, acompañarlos. Proporcionar información práctica o solo escuchar, escuchar de verdad.

Hay que **evitar frases** como "¿No se dieron cuenta de lo que ocurría? ¿Dijo algo y no se le tomó en serio? ¿No hubo ninguna señal que les hiciera sospechar?". Este tipo de frases, y otras del estilo, son inútiles y lo único que hacen es incrementar la culpa que sienten los familiares. No realizaremos juicios de valor con la familia.

Hay que mantener la calma y encontrar la mejor forma de proceder y responder a las necesidades de los supervivientes. Fomentar que expresen sus emociones y dejarles claro que son sentimientos normales en estas circunstancias. Hacerles preguntas que los ayuden a verbalizar su dolor. Dar información sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que vamos a hacer(30).

En caso de fallecimiento, explicaremos con claridad que, al no ser una muerte natural, deben realizar una autopsia y que el cuerpo de su ser querido quedará bajo la custodia de Fuerzas de Seguridad hasta que lo indique la autoridad judicial y que todo el proceso de velatorio se retrasará hasta que lo indique el forense.

Ofreceremos a la familia la opción de si quieren avisar a otras personas para darles el soporte que necesitan en ese momento.

Expertos en el tema destacan la necesidad de dejarles información escrita[12]. La información verbal a veces se olvida o se recuerda de forma desorganizada y confusa. Ofrecer a la familia información por escrito, clara y directa, con asociaciones a las que poder acudir, páginas web de referencia, Apps de ayuda, teléfonos de apoyo, como el teléfono de la Esperanza, etc. puede ayudar a la familia en momentos posteriores.

Solo si la familia/allegados lo verbalizan, se recogerá información relacionada con:

- Cambios en el comportamiento de esa persona
- Hechos relevantes en su contexto relacional que le podrían haber afectado
- Conductas llamadas "de cierre" que podría haber realizado la persona antes del suicidio (despedidas muy cariñosas, eliminar perfil de redes sociales, regalar objetos de valor sentimental, etc.)(21)

[12] Información que tenemos que elaborar. Como referencia para su elaboración tenemos los del Hospital Costa del Sol de Marbella y las Guía sobre prevención del Suicidio de la Consejería de Salud https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2019/guia_prevencionsuicidio.pdf

A estas personas les queda un largo y doloroso tránsito para procesar lo ocurrido y para superar un duelo que es muy distinto al de otras pérdidas. Nuestra actitud debe ser compasiva, siendo muy conscientes de que somos el soporte para esas personas en los primeros momentos.

7.3 Atención a personas por otros motivos (No intentos de suicidio) con Comunicación suicida o deseos de muerte

El reconocimiento de los intentos de suicidio por los profesionales de nuestro ámbito puede contribuir a la prevención de una recaída. Ser capaces de detectar la ideación y el comportamiento suicida es de gran importancia para el manejo del riesgo y el resultado de las terapias de salud mental, y pueden reducir las autolesiones hasta en un 50%(31).

Los/as profesionales de los servicios de urgencias y emergencias prehospitalarios estamos en un entorno estratégico y muy adecuado para poder hacer estas detecciones y derivar a los recursos más apropiados para cada persona.

En aquellas situaciones en las que durante la atención sanitaria (por otros motivos distintos al intento o crisis suicida), la persona verbalice **ideación suicida**, debemos abordar esta situación con las herramientas y elementos descritos en el apartado 7.1. La entrevista con el/la paciente se dirigirá tal y como se indicó en ese apartado, con el uso de las escalas y la información que debemos indagar a este respecto para hacer una toma de decisiones acorde a esta comunicación que nos hace la persona atendida.

En los casos en los que haya **criterios que "agravan" la ideación**, y que obtendremos de las herramientas descritas en el apartado 7.1, la persona debe ser valorada por especialista a la mayor brevedad posible.

La única vía actual para esta valoración urgente es el SUH.

El recurso a utilizar para este traslado se decidirá en función de la valoración que se haya hecho del paciente y su entorno, del lugar de asistencia y los recursos disponibles, con la máxima garantía para la persona atendida.

En los casos en los que no haya **ningún criterio que agrava la ideación** y la persona pueda ser valorada en otro momento:

- Indicaremos que pida cita a su MF constatando esta derivación en la HCD_M
- Derivaremos a SR para llamada de seguimiento[13]
- Facilitaremos información sobre recursos que puede utilizar[14]: teléfonos de ayuda, webs, asociaciones locales, etc., mientras se produce la cita para valoración.

Estas resoluciones se modificarán cuando los expertos en el tema establezcan otras vías de atención preferentes o más directas con las Unidades de Salud Mental Comunitaria.

Al margen de lo anterior, constatamos que no son pocas las ocasiones en las que, durante la atención de una persona por situaciones que nada tienen que ver con el suicidio, escuchamos **expresiones relacionadas con la muerte.** Con deseos explícitos de morir, expresado de formas muy variadas. Estas expresiones nos deben alertar y lejos de minimizarlas o evadirlas, debemos indagar sobre el malestar emocional o sufrimiento que pueda estar experimentando esa persona.

La *National Action Alliance for Suicide Prevention* promueve 7 elementos basados en la evidencia, que es importante conocer en estos casos(23):

- Poner el foco sobre el riesgo de suicidio para abordar el equilibrio entre factores que puedan contribuir o reprimir las ideas de suicidio.
- Tratar los desórdenes mentales subyacentes que a menudo contribuyen a la experiencia del sufrimiento (ansiedad, depresión, etc.), falta de control (abuso de sustancias) u otros como el insomnio, que habitualmente es ignorado y que en situaciones de riesgo, puede precipitar el suicidio.
- Valorar y atender las comorbilidades que pueden contribuir al sufrimiento, como el dolor, insomnio, la disnea en algunas enfermedades crónicas.

---

[13] Se trabajará con Salud Responde este protocolo.

[14] Esta información se elaborará con ayuda de expertos y se pondrá a disposición de los/as profesionales en las Unidades asistenciales para entregar en los casos que proceda.

- Utilizar intervenciones específicas que han mostrado reducción de riesgo de suicidio y que tienen que ver con el plan de seguridad para esa persona, como la revisión de sus razones para vivir, distracciones, técnicas de regulación emocional, soporte relacional, contactos profesionales (teléfonos de ayuda, terapias con especialistas…)
- Asegurar con la familia que hay un entorno seguro y no hay acceso a agentes letales, como armas de fuego o el control adecuado de la medicación que toma el/la paciente. De igual forma es importante conocer de forma más amplia los psicofármacos que esté tomando el paciente o que podamos prescribir en determinadas situaciones.
- Factores contextuales de la persona. El soporte social es un factor protector muy importante y la falta del mismo, un factor precipitante, más aún para personas que sufren discriminación o experiencias adversas.
- Coordinación de cuidados. Establecer nexos y transferencias adecuadas entre diferentes niveles de cuidados.

En los casos en los que queda claro que no estamos ante una conducta suicida, sino ante la verbalización de estos deseos o expresiones de muerte, y siempre que no requiera ningún procedimiento de urgencia, consensuaremos con esa persona y su familia que se quede en domicilio. Informaremos de los recursos que tienen disponibles para valoración y seguimiento preventivo[15].

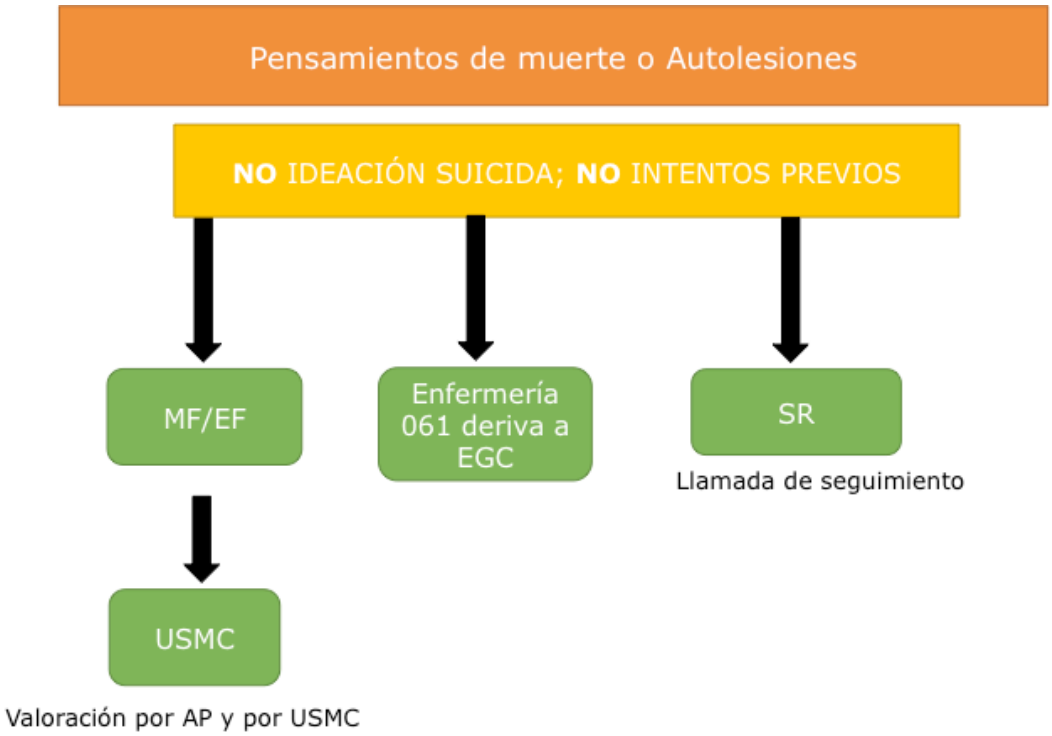
Estos recursos de valoración y seguimiento son, en primer lugar, su Equipo de referencia de Atención Primaria: Médico/a de Familia (MF)/Enfermero/a de Familia (EF). Serán estos profesionales quienes hagan la derivación al equipo de Salud Mental Comunitaria tras la valoración de la persona (Esquema 2).

En el caso de que esta persona ya tenga historia en Salud Mental, se debería agilizar la cita con Salud Mental Comunitaria para evitar retrasos en la atención especializada. Este punto queda pendiente de la revisión por Atención Primaria para su inclusión en el protocolo y establecer los pasos a seguir para conseguirlo.

[15] Se entregará información por escrito cuando esté disponible.

Independientemente de los antecedentes de la persona atendida, la enfermera del Equipo 061 hará una derivación a Enfermero/a Gestor/a de Casos (EGC). Esta derivación también puede facilitar la valoración de su equipo de referencia de Atención Primaria y de aquellos profesionales que la EGC estime que deben intervenir en su evaluación. En estos casos también haremos derivación a Salud Responde para que realice llamadas de seguimiento[16] previamente al contacto con sus referentes de AP. Si el soporte familiar es adecuado, debemos fomentar su implicación en mantener o incorporar las medidas de seguridad que sean precisas.

A estas personas también deberíamos entregarles información por escrito con teléfonos de ayuda, asociaciones locales, Apps, sitios web, etc. para que puedan obtener ayuda en caso de que así lo requieran previo a la cita con AP.



Esquema 2. En el caso de no requerir ninguna atención de urgencia.

No existe CIE-10 para este aspecto concreto. La propuesta sería: R45.2 Infelicidad

En relación a los Cuidados de Enfermería, hay descritos en el Anexo 3 algunos Diagnósticos NANDA que podrían describir la situación que está viviendo esa persona.

[16] Se desarrollará este protocolo con Salud Responde.

RECOMENDACIONES SOBRE EL IMPACTO EN PROFESIONALES SANITARIOS

El procedimiento no recoge una evidencia sobre la que existe abundante literatura científica y sobre la que el grupo de trabajo autor de este documento quiere hacer varias sugerencias:

Las organizaciones deben atender las emociones y sentimientos que este tipo de eventos provocan en los profesionales. La gestión emocional y la atención al profesional en este sentido es una necesidad detectada en nuestro ámbito, que genera la obligación de disponer de apoyo/terapia psicológica para profesionales tras asistir casos de conducta suicida de gran impacto emocional.

Nuestras emociones pueden interferir durante la intervención en las demandas sanitarias, dando lugar a la sobreimplicación o al rechazo. También estas asistencias pueden suponer una sobrecarga emocional para el/la profesional con consecuencias en su propia salud. Existen estrategias de autocuidado para proteger nuestro bienestar ya que repercute directamente en la atención que damos a los/las pacientes con conducta suicida. Además de aprender a gestionar nuestras emociones, tenemos que hacer un trabajo reflexivo e individual acerca de nuestras carencias, expectativas, vulnerabilidades y también de nuestras fortalezas y recursos personales para afrontar las adversidades que se nos presentan a lo largo de la vida. También conocer cómo de satisfechos estamos con nuestro proyecto vital para, de esta forma, ser más útiles para poder colaborar en que el/la paciente recupere el suyo.

Además, tenemos que aprender a identificar las fuentes de tensión externas e internas que emergen durante el desempeño de nuestras funciones. También reconocer cómo los estados de tensión surgidos durante la realización de nuestro trabajo afectan de diferente forma y grado al adecuado desempeño laboral y a las diferentes esferas de nuestra vida (física, emocional, relaciones de pareja, relaciones sociales), etc.

A partir de este análisis, construir un plan de autocuidado que contemple:

- Formación en la atención de las personas con conducta suicida.
- Uso de Guías de Autocuidado que ofrece la Consejería de Salud (ej: práctica de Mindfulness).
- Rutinas de actividad física, hábitos de alimentación equilibrada, sueño adecuado, etc.
- Participar en espacios colectivos de intercambios de experiencias.

Y todas aquellas que seamos capaces de desarrollar entre todos/as para fomentar una adecuada salud mental de los/as profesionales de la atención urgente y emergente prehospitalaria.

ANEXOS

ANEXO 1. FACTORES DE RIESGO

Se exponen algunos gráficos de fuentes diversas con los factores de riesgo que hasta el momento se han identificado en estas situaciones.

Imagen autorizada por la Asociación papageno www.papageno.es

Factores de Riesgo

Sociodemográficas

Ser varón, adolescente o tener una edad avanzada. Ser soltero o viudo y residir en una zona rural, nivel económico y socioeducativo bajo. Pertenencia a una minoría étnica o sexual.

Personales

PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICOS. Pérdidas de salud u hospitalización. Enfermedad que cursa con dolor, incapacidad, rechazo social, alta tasa de mortalidad o incurable.

TRASTORNOS MENTALES: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, adicciones, trastornos de alimentación, trastorno límite de personalidad, antisocial y disocial o narcisista.

VARIABLES PSICOLÓGICAS: Ser una persona, agresiva, violenta, impulsiva u obsesiva. Baja autoestima, falta de control, labilidad o pérdida de la seguridad o dependencia emocional. Intolerancia a la frustración, impulsividad, desesperanza. Falta de habilidades sociales, timidez e hipersensibilidad a la crítica.

FACTORES RELACIONADOS CON CONDUCTAS SUICIDAS PREVIAS. Tener acceso a métodos letales, un plan suicida o presencia de notas de suicidio. Hablar sobre su propia muerte con ambivalencia entre morir o vivir. Intentos de suicidio o autolesiones previas.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA física, psíquica, y/o sexual. De género, maltrato infantil, mobbing, bullying o ser víctima de humillación. Víctima de guerras, terrorismo o desastres naturales.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

Familiares

CARENCIA DE APOYO FAMILIAR. Tener una familia disfuncional, conflictiva, desorganizada o problemática o con problemas de comunicación.

EMBARAZO NO DESEADO.

ANTECEDENTES FAMILIARES de intentos de suicidio, consumo de alcohol o drogas o trastornos mentales.

DUELO. Ausencia de padres, divorcio o muerte. Pérdidas o separación de otras personas significativas.

BAJO NIVEL EDUCATIVO del grupo familiar.

PROBLEMAS ECONÓMICOS O POBREZA.

Sociales

APOYO SOCIAL: Aislamiento, falta de apoyo social, soledad. Presencia de problema sociales. Problemas con la ley.

VARIABLES SOCIOSANITARIAS: Falta de accesibilidad a servicios de salud y educación o a actividades laborales, culturales y recreativas.

EXPOSICIÓN A VIOLENCIA, lugar de residencia inseguro o con clima de violencia, terrorismo, guerras y desastres.

ALTA INCIDENCIA DE ALCOHOLISMO Y OTRAS ADICCIONES.

EXPOSICIÓN AL SUICIDIO DE OTRA PERSONA o suicidios sensacionalistas, suicidio por contagio. Comportamiento suicida aceptado.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS ADVERSOS. Deterioro socioeconómico de la comunidad.

PAPAGENO
www.papageno.es

Table 2 Pooled estimates of risk factors for suicide, by domain

Sociodemographic domain
Social isolation
Unemployment
Low socioeconomic status
Low education
Single/not married
Low income
Living alone
Not religious
Not having children
Family history domain
Mental disorder
Suicide
Suicide attempt

Adverse life events
Relationship conflict
Legal problems
Family-related conflict
Abuse/victimisation
Financial problems
Early separation from parents
Work/school-related conflict
Bereavement
Timing of life events
Within past month
Within past 6 months
Within past 3 months

Clinical domain
Any mental disorder
Depression
Schizophrenia spectrum disorder
Bipolar disorder
Substance use disorder
Alcohol use disorder
Drug use disorder
Anxiety disorder
Dysthymia
Any personality disorder (PD)
Borderline PD
Paranoid PD
Dependent PD
Avoidant PD
Antisocial PD
Psychiatric treatment
History of self-harm
Previous suicide attempt
Smoking
Physical illness

Nota: 40 Factores de riesgo agrupados en 4 grandes grupos. Del estudio de Favril L, Yu R, Uyar A, et al. Risk factors for suicide in adults: Systematic review and meta-analysis of psychological autopsy studies. Evid Based Ment Health. 2022;10:1-8.

Imagen autorizada por Dr. Fazel, autor de correspondencia del artículo.

Imagen autorizada por la Asociación papageno www.papageno.es

ANEXO 2. FACTORES PROTECTORES

ANEXO 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Otros Diagnósticos que podemos encontrar en estas personas:

NANDA

00053 Aislamiento social

00054 Riesgo de Soledad

00055 Desempeño ineficaz del rol

00060 Interrupción de los procesos familiares

00063 Procesos familiares disfuncionales

00066 Sufrimiento espiritual

00119 Baja autoestima crónica

00120 Baja autoestima situacional

00124 Desesperanza

Criterios de resultado (NOC)

1201 Esperanza

1204 Equilibrio emocional

1205 Autoestima

1206 Deseo de vivir

1208 Nivel de Depresión

1306 Dolor: respuesta psicológica adversa

1309 Resiliencia personal

1504 Soporte social

Hay indicadores muy relevantes que podemos detectar en estas situaciones en cada uno de los NOC propuestos.

Intervenciones de enfermería NIC

Serán las que se ajusten a la situación de la persona en ese momento de la asistencia. Recomendamos algunas de las NIC específicas relacionadas con el riesgo de conducta suicida y con algunos de los DdE mencionados previamente:

4920 Escucha activa

5310 Dar esperanza

5460 Contacto

5270 Apoyo emocional

5340 Presencia

6480 Manejo ambiental

4420 Acuerdo con el paciente

6340 Prevención del Suicidio

8100 Derivación

8140 Transferencia de Cuidados del paciente: Destacando el uso de método de seguridad (ISOBAR) y la preparación del paciente para la transferencia. Advertirle de que vamos a comentar en su presencia todo lo ocurrido para que continúen con la atención que requiere. Hacer un relato respetuoso de lo ocurrido, de lo que hemos hablado con esa persona, de lo que hemos objetivado y hacer partícipe a la persona, si la situación lo permite, para añadir o comentar lo que considere.

METODOLOGÍA

La Escuela Andaluza de Salud Pública lleva trabajando más de una década en la prevención del suicidio con el objetivo de dar más coherencia a todas las iniciativas y actuaciones que ya se están desarrollando y de impulsar nuevas estrategias, con mayor nivel de coordinación. Además, acumula experiencia en el terreno de la intervención prehospitalaria, concretamente para la atención a pacientes de paliativos. Para el presente proyecto de atención prehospitalaria a las personas con conducta suicida ofrece apoyo metodológico mediante soporte en la organización, dinamización y asesoramiento de los grupos de trabajo en el desarrollo de contenidos y elaboración de protocolos.

Para ello, se crearon tres grupos motores, en base a las tres actividades principales de este ámbito de atención: la coordinación sanitaria de urgencias y emergencias, la asistencia sanitaria y la atención desde Salud Responde. Los grupos han estado compuestos por un total de 18 profesionales con representación de diferentes perfiles (gestore/as telefónico/as, enfermera/os, enfermera/os, médicos, gestora de calidad) y de la red de salud mental del SAS en atención hospitalaria y en unidades de salud mental comunitaria (psicólogos, psiquiatras). Cada uno de los grupos ha contado con un coordinador/a.

De julio de 2022 a enero de 2023 se han realizado un total de 22 reuniones. En una primera reunión virtual conjunta con coordinadore/as de grupo se llevó a cabo una presentación y primera definición de objetivos. Después se realizaron reuniones virtuales de frecuencia quinquenal con cada uno de los grupos de trabajo. Para finalizar, una última reunión presencial con la asistencia de todos los grupos para la puesta en común, y el debate y retroalimentación entre los grupos y sus correspondientes protocolos.

En todas las reuniones, ha participado como moderadora una misma técnica de proyecto y un mismo miembro del Centro de Emergencias Sanitarias de Andalucía con el fin de servir de puente y facilitar la comunicación y la coherencia entre los protocolos. Además de las reuniones, se ha realizado un trabajo continuado a través de la plataforma virtual de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que incluye foros y posibilidad de compartir documentos, creando un repositorio de todos los consultados.

Concretamente, el grupo asistencial ha estado formado por 5 profesionales de enfermería, medicina, psicología y psiquiatría.

Además de las reuniones quincenales, el grupo de trabajo asistencial ha realizado otras 12 reuniones para avanzar en el desarrollo del protocolo. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en PubMed y Web Of Science con los términos de búsqueda: *"suicide", "emergency medical services", "ambulances", "prehospital emergency care"*, sin restricción de fechas hasta diciembre de 2021. Se va completando la búsqueda con actualizaciones durante el año 2022, y con revisión inversa. La bibliografía consultada se amplía también a literatura gris (tesis doctorales, documentos internos de servicios de Salud Mental de nuestra geografía, libros y capítulos de libros sobre el tema tratado, informes de instituciones reconocidas a nivel mundial, artículos de prensa, etc.). Se analizan en profundidad 57 referencias bibliográficas para llevar a cabo este trabajo.

Continuaremos con la búsqueda y el aprendizaje sobre este tema para las siguientes revisiones que se lleven a cabo de este documento de trabajo.

ACRÓNIMOS

ACO: Anticoagulantes orales

ADNI: Antidiabéticos no insulínicos

AP: Atención Primaria

AVD: Actividades de la vida diaria

CCUE: Centros de Coordinación de urgencias y emergencias

CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades

CMT: Malos Tratos Confirmados

EF: Enfermera de Familia

ECA: Equipo 061 de Coordinación Avanzada

EGC: Enfermera Gestora de casos

EPI: Equipos de Protección Individual

FEA: Facultativo especialista de área

GCS: Glasgow Coma Scale

HCD_M: Historia Clínica Digital en Movilidad

ISMT: Indicador de Sospecha de Malos Tratos

LGTBQ: Lesbiana, gay, transgénero, bisexual, queer

MF: Médico/a de Familia

NB: Necesidades Básicas

NIC: Clasificación de intervenciones de Enfermería

NOC: Clasificación de resultados de Enfermería

OVM: Ocular – Verbal – Motor (De la GCS)

SR: Salud Responde

SUH: Servicio de Urgencias Hospitalario

TD: Tipo de Demanda

UGCSM: Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental

USMC: Unidad de Salud Mental Comunitaria

BIBLIOGRAFÍA

1. De Berardis D, Martinotti G, Di Giannantonio M. Editorial: Understanding the complex phenomenon of suicide: From research to clinical practice. Front Psychiatry. 2018;9(MAR):9–12.

2. Carmona-Navarro MC, Pichardo-Martínez MC. Attitudes of nursing professionals towards suicidal behavior: influence of emotional intelligence. Rev Lat Am Enfermagem [Internet]. 2012 Dec;20(6):1161–8. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692012000600019&lng=en&tlng=en

3. Levi-Belz Y, Gvion Y, Apter A. Editorial: The psychology of suicide: The research understandings to intervention and treatment. Front Psychiatry. 2019;10(APR):1–4.

4. Instituto Nacional de Estadísitica. Defunciones según la causa de muerte. Año 2.020 [Internet]. Notas de Prensa. 10 de Noviembre de 2.021. 2020. Available from: https://www.ine.es/prensa/edcm_2020.pdf

5. Goñi Sarriés A, Zandio Zorrilla M. Suicide: The challenge of prevention. An Sist Sanit Navar. 2017;40(3):335–8.

6. Organización Panamericana de la Salud. Prevención del Suicidio. Un imperativo global [Internet]. Washington, DC: OPS, 2014.; Available from: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54141/9789275318508_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7. Verrocchio MC, Carrozzino D, Marchetti D, Andreasson K, Fulcheri M, Bech P. Mental pain and suicide: A systematic review of the literature. Front Psychiatry. 2016;7(JUN).

8. Pacheco Tabuenca T, Robles Sánchez JI. Emergencias extrahospitalarias: el paciente suicida. Sanid Mil [Internet]. 2011 Dec;67(4):345–53. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712011000500003&lng=en&nrm=iso&tlng=en

9. Favril L, Yu R, Uyar A, Sharpe M, Fazel S. Risk factors for suicide in adults: Systematic review and meta-analysis of psychological autopsy studies. Evid Based Ment Health. 2022;10:1–8.

10. World Health Organization. Suicidio [Internet]. 17 de Junio de 2.021. 2AD. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

11. Duncan EAS, Best C, Dougall N, Skar S, Evans J, Corfield AR, et al. Epidemiology of emergency ambulance service calls related to mental health problems and self harm: a national record linkage study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med [Internet]. 2019 Dec 20;27(1):34. Available from: https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-019-0611-9

12. Tabuenca TP. Factores predictores de la conducta suicida y actuaciones preventivas en el ámbito extrahospitalario [Internet]. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología; 2016. Available from: https://eprints.ucm.es/id/eprint/38876/

13. Cabeza FV. MORIR ANTES DEL SUICIDIO: PREVENCIÓN EN LA ADOLESCENCIA. HERDER, editor. Barcelona: HERDER; 2022. 256 p.

14. Silverman MM, Berman AL, Sanddal ND, O'Carroll PW, Joiner TE. Rebuilding the Tower of Babel: A Revised Nomenclature for the Study of Suicide and Suicidal Behaviors Part 2: Suicide-Related Ideations, Communications, and Behaviors. Suicide Life-Threatening Behav [Internet]. 2007 Jun;37(3):264–77. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1521/suli.2007.37.3.264

15. (avalia-t) A de A de TS de G. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. I. Evaluación y Tratamiento. Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud [Internet]. 2020. Available from: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf

16. Paton F, Wright K, Ayre N, Dare C, Johnson S, Lloyd-Evans B, et al. Improving outcomes for people in mental health crisis: A rapid synthesis of the evidence for available models of care. Health Technol Assess (Rockv). 2016;20(3).

17. Todorova L, Johansson A, Ivarsson B. Perceptions of ambulance nurses on their knowledge and competence when assessing psychiatric mental illness. Nurs Open [Internet]. 2021 Mar 27;8(2):946–56. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nop2.703

18. Díaz M, Andrade-Conde E, Cherino J, Montalvo J, Fernandéz E, Rivas-Ruiz F. Creencias actitudinales sobre la conducta suicida en profesionales sanitarios del área sanitaria de la Costa del Sol Occidental. Actas Esp Psiquiatr [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 3];49(2):57–63. Available from: https://www.mendeley.com/catalogue/a0197bdc-78a5-3895-9833-e7039cb30c0a/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bf5329dfc-529b-4b74-adfe-e4c70e89310a%7D

19. Suicide Prevention Resource Center. The role of emergency medical services providers in preventing suicide. 2013;1–8.

Available from: http://www.sprc.org/sites/sprc.org/files/ems.pdf

20. Shirzad F, Gholamzad S, Shafiee M, Shariat SV. Development of a pre-hospital emergencies protocol for the management of suicidal patients in Iran. BMC Emerg Med. 2021 Apr;21(1):47.

21. Martín-Barrajón P. 5.5. Decálogo de Prevención. In: Abordaje integral de prevención de la conducta suicida y autolesiva Una mirada educativa para familias y profesionales Luis Fernando López Martín (Coord) [Internet]. Madrid: Editorial Sentir; 2023. p. 184. Available from: https://editorialsentir.com/libro/abordaje-integral-de-prevencion-de-la-conducta-suicida-y-autolesiva-9788426735119/

22. National Institute for Health and Care Excellence. Suicide prevention [Internet]. 2022. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/qs189/resources/suicide-prevention-pdf-75545729771461

23. Brent DA, Oquendo MA, Reynolds CF. Caring for Suicidal Patients. JAMA Psychiatry [Internet]. 2019 Aug 1;76(8):862. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2735126

24. González González M, García-Haro J, García-Pascual H. Evaluación contextual-fenomenológica de las conductas suicidas. Evaluación Context las Conduct suicidas [Internet]. 2019;39(135):15–31. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352019000100002

25. Kohtala S. Ketamine—50 years in use: from anesthesia to rapid antidepressant effects and neurobiological mechanisms. Pharmacol Reports [Internet]. 2021;73(2):323–45. Available from: https://doi.org/10.1007/s43440-021-00232-4

26. Mohr P, Masopust J, Kopeček M. Dopamine Receptor Partial Agonists: Do They Differ in Their Clinical Efficacy? Front Psychiatry. 2022;12(January):1–15.

27. Grupo regional de Cuidados de EPES. Cuidados de Enfermería en la atención extrahospitalaria [Internet]. Andalucía; 2019. Report No.: Rev_4. Available from: http://www.epes.es/wp-content/uploads/manual-cuidados-enfermeria.pdf

28. EPES GR de C de. Detección de paciente vulnerable. Derivación a Enfermera Gestora de casos. Andalucía; 2018. Report No.: Rev_3.

29. Alegre CS. ¿Hablamos del Suicidio?. Una realidad escondida contada a través de una historia real. [Internet]. Primera. Editorial Planeta SAU, editor. Universo de Letras; 2021. 133 p. Available from: www.universodeletras.com

30. Nilsson C, Bremer A, Blomberg K, Svantesson M. Responsibility and compassion in prehospital support to survivors of suicide victim – Professionals' experiences. Int Emerg Nurs [Internet]. 2017 Nov;35:37–42. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1755599X17300162

31. Pajonk FG, Schmitt P, Biedler A, Richter JC, Meyer W, Luiz T, et al. Psychiatric emergencies in prehospital emergency medical systems: a prospective comparison of two urban settings. Gen Hosp Psychiatry. 2008;30(4):360–6.

Este documento se revisará para incluir todo lo relativo a la activación del **CÓDIGO SUICIDIO** cuando esté acordado e implantado con los grupos de trabajo locales liderados por las UGCSM en cada provincia.

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo